

تصوير الإحليل التراجعي — أو RUG — فحص بالأشعة السينية يلتقط صوراً للإحليل (مجرى البول)، وهو الأنبوب الذي يخرج منه البول من الجسم. تُحقن كمية صغيرة من صبغة التباين في الإحليل بلطف كي تظهر بوضوح في الأشعة. يساعد ذلك الجراح على تحديد أي تضيق أو ندبة أو إصابة وقياسها قبل تخطيط العلاج.

عن هذا الفحص

قد يصعب رؤية النسيج الندبي أو التضيق داخل الإحليل — المعروف بـ **تضيق الإحليل (stricture)** — في الفحوصات العادية. يملأ RUG الأنبوب بصبغة خاصة تظهر بيضاء في الأشعة، مما يرسم "خريطة واضحة" للإحليل من الداخل.

قد يطلب جراحك إجراء RUG من أجل:

- تحديد موضع التضيق أو الندبة وقياس طولها بدقة
- فحص الإحليل بعد إصابة
- التخطيط لعملية جراحية لإصلاح الإحليل
- متابعة التعافي بعد الإصلاح الجراحي

يُظهر الفحص القناة المفتوحة داخل الإحليل — المسار الذي يسلكه البول. لا يفحص الكليتين، وليس علاجاً؛ بل هو صورة ترشد الخطوات القادمة.

هل هو آمن؟

نعم. RUG فحص شائع ومنخفض الخطورة. كمية الأشعة المستخدمة صغيرة، والصبغة مائية تخرج مع البول. يشعر معظم المرضى بانزعاج خفيف وعابر فقط. الآثار الجانبية النادرة — كعدوى بولية أو نزيف بسيط أو صعوبة مؤقتة في التبول — عادةً خفيفة وتزول بسرعة.

تعلم المصطلحات

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم.

تضيق الإحليل (Stricture)

منطقة ضيقة أو مندوبة في الإحليل تُعيق تدفق البول أو تُوقفه.

صبغة التباين

سائل يظهر بوضوح في الأشعة السينية ليكشف الجزء الداخلي من الإحليل.

القسطرة (Catheter)

أنبوب رفيع ومرن. في هذا الفحص، يُوضع طرفه فقط عند فتحة الإحليل دون إدخاله بالكامل.

التنظير الفلوري (Fluoroscopy)

نوع من الأشعة السينية يُظهر صوراً متحركة مباشرة أثناء تدفق الصبغة.

فوهة الإحليل (Meatus)

الفتحة عند طرف القضيب التي يخرج منها البول.

مزرعة البول

فحص سريع لعينة بول للتحقق من وجود عدوى قبل الإجراء.

جراح المسالك البولية الترميمي

جراح متخصص في الجهاز البولي وإصلاح الإحليل.

هل سيؤلم؟ يشعر معظم المرضى بضغط خفيف أو وخز عابر أثناء حقن الصبغة، وليس ألماً حاداً. يمكن للفريق إبطاء الإجراء في أي وقت — أخبرهم فوراً إن شعرت بأي إزعاج. يستغرق الفحص نحو 15-30 دقيقة.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

لا يتطلب الاستعداد جهداً كبيراً. في معظم الحالات:

- يمكنك تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي — لا حاجة للصيام إلا إذا أرشدك فريقك.
- استمر في تناول أدويةك المعتادة ما لم يطلب منك الفريق إيقاف أيٍّ منها.
- يمكنك عادة قيادة سيارتك للعودة، إذ لا يحتاج معظم المرضى إلى تهدئة.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- سبق أن عانيت من تفاعل مع صبغة تباين الأشعة أو اليود
 - تتناول مضادات التخثر (مميّعات الدم)
 - تعاني من أعراض عدوى بولية (حرقة، حمى، أو بول عكر ذو رائحة حادة) — قد يستوجب ذلك تأجيل الفحص
- قد تُطلب منك عيّنة بول للكشف عن العدوى، وقد تُعطى مضاداً حيوياً قبل الفحص أو بعده لتقليل خطر العدوى.

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 تستلقي على طاولة الأشعة، عادةً مائلاً قليلاً على أحد جانبيك. يساعدك الفريق في اتخاذ الوضعية المناسبة.
- 2 تُنظّف فتحة القضيب، ويُوضع أنبوب صغير ومرن عند الفتحة فقط. قد يُنفخ بالون صغير بلطف لتثبيتته.
- 3 تُحقن الصبغة ببطء في الإحليل بينما تُلتقط الأشعة. قد يُطلب منك البقاء ثابتاً والتنفس بشكل طبيعي.
- 4 يتابع الفريق تدفق الصبغة على الشاشة ويلتقط عدة صور من زوايا مختلفة، ثم يُزال الأنبوب.

بعد الفحص

- يمكنك عادة العودة إلى المنزل واستئناف نشاطاتك فوراً.
- قد تشعر بحرقة خفيفة عند التبول ليوم أو نحوه. يساعد شرب كميات إضافية من الماء على تخفيفها.
- قد تلاحظ كمية صغيرة من الدم عند الفتحة أو احمراراً طفيفاً في البول. هذا أمر شائع ويزول عادةً خلال يوم.
- تُطرح الصبغة مع البول خلال ساعات قليلة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- صعوبة في التبول أو عدم القدرة على التبول كلياً
- نزيف غزير أو نزيف لا يتوقف
- ألم يزداد سوءاً بدلاً من التحسّن

ثلاثة أمور تذكّرها

1. RUG فحص سريع وآمن بالأشعة السينية يرسم خريطة الإحليل بصبغة خاصة — يساعد جراحك على تخطيط العلاج المناسب.
2. الاستعداد بسيط: تناول طعامك وشرابك وأدويةك المعتادة — لكن أخبر فريقك بأي حساسية للصبغة أو مميّعات دم أو أعراض عدوى بولية.
3. يشعر معظم المرضى بضغط عابر فقط ويعودون فوراً. الحرقة الخفيفة أو الدم اليسير ليوم أمر طبيعي — اشرب ماءً إضافياً واتصل بفريقك عند حدوث حمى أو نزيف غزير أو صعوبة في التبول.